



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : عيبر كمال ابوطالب ابراهيم
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : العياط
رقم البطاقة : 28903182100345 رقم التليفون : 01143681475
العنوان : كفر شحاته
العمر (تاريخ الميلاد) : 18-03-1989 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 22-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: عبيد كمال ابوطالب ابراهيم National ID: 28903182100345	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



عبد
كمال ابوطالب ابراهيم
كفر شحاته
مركز العياط - الجيزة

١٩٨٩/٨

٢٨٩ . ٣ ١٨ ٢١ . ٠٣ ٤٥

IW6155982

١١ ٤٣٦٨١٤٧٥

١١ ٢٣ / ٣٩١ - ٢

ع



٢٠٢١/٠٥ ٢٨٩٠٣١٨٢١٠٠٣٤٥

ربة منزل



انثى مسلمة متزوجة

نادى عبدالنواب عبدالسلام محمد

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٥/٠٣



mm/dd/yyyy

ED

MDT FORM

Name: <u>عبد كمال أبو طالب إبراهيم</u>	MRN: 10922
Age: 37 Y	ID:
Menopausal Status: PRE	Phone: 01134681475
NRS SCORE:	Marital Status: MARRIED
BMI:	Family History: -VE
CO Morbidity: M:FREE	Reason Of MDT: NEW

Clinical Data:

BX: LT IDC G2
ER 7/8 PR 7/8 HER +1 K167 70

Sonomammography:

ACR B:LT LOQ MASSES INDEX AT O'CLOCK
2.2*1.5CM & RETRO-AREOLAR IRREGULAR MASS
1.7*1.1CM (MULTIFOCAL)
PATHOLOGICAL LN MORE THAN 3

Mets Workup:

CT CAP:FREE
BONE SCAN:FREE

History:

37YO PREMENOPAUSAL ON IUD M:FREE
LEFT IDC LUMINAL B
CLINICALLY > 2CM T3 MULTIFOCAL N2 MO , NO
NIPPLE DISCHARGE
LARGE BREAST SIZE

Recommendations:

FOR POSSIBILITY OF CLIPPING BOTH LESION NACT
THEN LT WLE + ALND GUIDED BY CLINICAL

MDT Outcome & Plan

-clipping OF BOTH BREAST LESION
-NACT >> AC X4 , TAXOTERE X 4
-CLINICAL EXAMINATION EVERY 2 CYCLES BY
BREAST US

R

L



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د. محمد كمال					

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: عبير كمال ابوطالب ابراهيم

Age: 37years

Sex: female

Request type: مبادره

Sub request type:

Hospital no:

Pathology no.:256B-2026

Department: صحة مرآه

Date of result:5/5/2026

Referred by: د/هبة زام

Date of biopsy:27/4/2026

Nature of specimen: tru-cut biopsy

I.D. Number:28903182100345

Clinical diagnosis: left breast mass

Gross pathology : Muliplte grayish white tissue cores up to 0.7cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique: Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER- PR- Her2- Ki67

Microscopic picture: Section examined revealed core of tumor showing invasive duct carcinoma of no special type (NST). The tumor forms of anaplastic ductal cells infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing moderate tendency to form tubules. There is moderate number of mitotic figures. The tumor showed moderate lymphocytic infiltration. No ductal carcinoma insitu is seen.

Immunohistochemical Result;

ER: Moderate nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 7/8).

PR: Moderate nuclear staining of 90% of tumor cells (Allred Score 7/8).

Her2: Faint incomplete membranous staining of >10% of tumor cells (Score 1+)

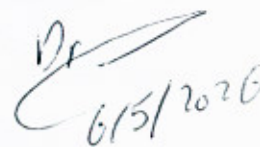
Ki67: Positive nuclear staining of 70% of tumor cells

Diagnosis: Left Breast Mass, Tru-Cut Biopsy:

Invasive Ductal Carcinoma, (NST) Grade II .

Signature:

Dr.Nermine Nabil.M.D



Pathology Lab. Manager

Nermine Nabil, M.D

Patient ID: abeer kamal	Patient Name English: abeer kamal
Age	2026/04/22 01:16:48 PM : Report Date

Women's Health Outreach Program
Bilateral Full field Digital Mammography

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Left breast

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- UOQ areas of focal asymmetries and architectural distortion with segmental distribution
- Retroareolar equal dense irregular mass.
- **Ultrasound** demonstrated
- UOQ hypoechoic irregular masses ,the index one noted at 1 o'clock zone b measuring about 22x15mm and about 3mm from underlying skin ,the deepest one at 1oclock zone c about 13x8mm.
- Retroareolar irregular hypoechoic mass with internal vascularity measuring about 17x11mm .
- dilated ducts reaching the nipple reaching the nipple non mass region .
- Enlarged Pathological axillary LNs level 1 more than 3 with lost hilum and some shows eccentric hilum.
- **Right breast**
 - Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
 - No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
 - **Ultrasound** demonstrated normal parenchyma
 - No solid or cystic lesion
 - Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
 - Non-specific axillary LNs.

Impression:

Left breast : UOQ multifocal malignant process with ipsilateral pathological lymphadenopathy for biopsy and histopathological assessment (BIRADS 5)

Right breast: Normal (BIRADS 1)

Dr.Reham
Rady,FEBR,FFBR

اسم المريض بالإنجليزية: aber kamal abw talb	كود المريض: 28903182100345
تاريخ التقرير: 2026/08/17 11:12:54 AM	السن: ٣٧ سنة, ٢ شهر

Contrast enhanced Spectral Mammography

CLINICAL SUMMARY: 37 years old female patient with pathologically proven invasive ductal with focal lobular carcinoma grade II (+ve ER 7/8, +ve PR 7/8, +I HER2 and Ki67= 70 %)

CC & MLO low energy & recombined (post contrast) images

FINDINGS:

Background Uptake: Mild background enhancement.

ACR: b (few dispersed fibroglandular densities)

Left breast:

- **Low energy (Non contrast) images:** left breast shows UOQ focal asymmetry with architectural distortion showing segmental distribution from retroareolar region to posterior third.
- **Recombined (Post contrast) images:** left breast shows UOQ non mass enhancement, segmental heterogeneous extending **from the nipple** to posterior one third measuring about 16.5 x. 8.3 x 10.5 cm at its TS, AP and CC diameters, moderate conspicuity, corresponding to the low energy findings.
- **Complementary US:**
 - The left breast shows non mass area of heterogeneous hypoechoic texture with architectural distortion mounting in few areas to mass formation , from 12 o clock to 4 o clock , the whole process is continuous through the whole formentioned area .
 - Few enlarged axillary lymph node at level I, II and III with focal cortical thickening, largest one measuring about 30 x 16 mm with effaced hilum .

Right breast:

- **Low energy (Non contrast) images** No asymmetry or distortion or suspicious grouped microcalcifications.
- **Recombined (Post contrast) images** show no pathological mass or non mass enhancement.
- Normal skin / nipple / areolar complex.
- **Complementary ultrasound:**
 - No cystic or solid masses.
 - No enlarged axillary LNs.

IMPRESSION:

- **RIGHT BREAST:** (BIRADS 2= normal) no significant abnormality detected.
- **LEFT BREAST:** (BIRADS 6= pathologically proven malignancy) left UOQ pathological process as described

Best regards,

DR. LAMIAA ADEL, MD

DR. MARWA HAKIM, MD

اسم المريض بالإنجليزية: abber kamal abw talb	28903182100345	كود المريض:
تاريخ الفحص: 2026/08/17 11:12:54 AM	السن: ٣٧ سنة ٢ شهر	

Contrast enhanced Spectral Mammography

CLINICAL SUMMARY: 37 years old female patient with pathologically proven invasive ductal with focal lobular carcinoma grade II (+ve ER 7/8, +ve PR 7/8, +I HER2 and Ki67= 70 %)

CC & MLO low energy & recombined (post contrast) images

FINDINGS:

Background Uptake: Mild background enhancement.

ACR: b (few dispersed fibroglandular densities)

Left breast:

- **Low energy (Non contrast) images:** left breast shows UOQ focal asymmetry with architectural distortion showing segmental distribution from retroareolar region to posterior third.
- **Recombined (Post contrast) images:** left breast shows UOQ non mass enhancement, segmental heterogeneous extending from the nipple to posterior one third measuring about 16.5 x. 8.3 x 10.5 cm at its TS, AP and CC diameters, moderate conspicuity, corresponding to the low energy findings.

▪ **Complementary US:**

- The left breast shows non mass area of heterogeneous hypoechoic texture with architectural distortion mounting in few areas to mass formation , from 12 o clock to 4 o clock , the whole process is continuous through the whole formationed area .
- Few enlarged axillary lymph node at level I, II and III with focal cortical thickening, largest one measuring about 30 x 16 mm with effaced hilum .

Right breast:

- **Low energy (Non contrast) images** No asymmetry or distortion or suspicious grouped microcalcifications.

- **Recombined (Post contrast) images** show no pathological mass or non mass enhancement.

- Normal skin / nipple / areolar complex.

▪ **Complementary ultrasound:**

- No cystic or solid masses.
- No enlarged axillary LNs.

IMPRESSION:

- **RIGHT BREAST:** (BIRADS 2= normal) no significant abnormality detected.
- **LEFT BREAST:** (BIRADS 6= pathologically proven malignancy) left UOQ pathological process as described

Best regards,

DR. LAMIAA ADEL, MD

DR. MARIWA HAKIM, MD